XXXI Congreso Colombiano de Cardiología y Cirugía CARDIOVASCULAR
CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA
2026 26·27·28 FEBRERO
CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL LAS AMÉRICAS

EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA REDUCIR BARRERAS GEOGRÁFICAS EN EL CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN: ANÁLISIS SECUNDARIO DEL RE-HOPE

Autores:, Alvaro Castañeda-Hernandez[1], Daniel Martínez-Bello[1], Lyda M. Herrera-Sánchez[1], M. Gabriela Serrano-Alarcón[1], Juan Miguel Girón[1], Claudia García[1], José P. López López[1], Johanna Otero[1], Alexander Torres[2], Patricio Lopez-Jaramillo[1]

1. Instituto de investigaciones MASIRA, Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia.
2. Secretaría de Salud de Santander, Bucaramanga, Colombia.

INTRODUCCIÓN

A pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión, su control en Colombia es bajo. La accesibilidad geográfica a los servicios de salud influye en el diagnóstico y tratamiento. El objetivo es evaluar la asociación entre la distancia de los centros de atención primaria (CAP), los niveles de presión arterial sistólica (PAS) y el control de hipertensión. Además, se evaluó si una intervención basada en trabajadores comunitarios de salud (TCS) reduce esta barrera.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio de implementación (RE-HOPE) en CAP de 13 municipios de Santander.

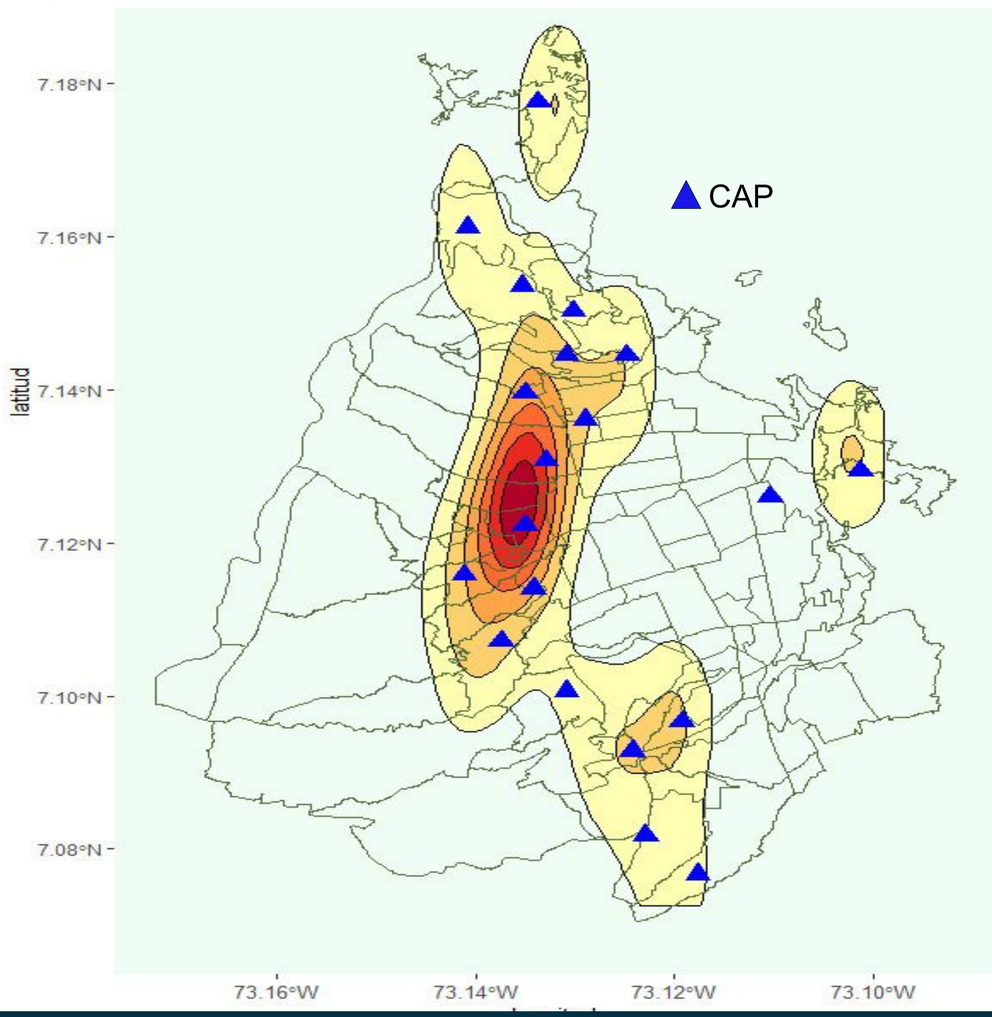
Población: Adultos con HTA (de novo, no controlada ≥140/90 mmHg o sin asistencia a programa de riesgo cardiovascular)

Intervención con TCS (5 visitas)
- Búsqueda activa
- Articulación con Centros de Atención Primaria
- Medición de presión arterial, educación en hipertensión y promoción de hábitos saludables.

Análisis espacial: Geocodificación manual de domicilios y CAP en Bucaramanga mediante QGIS v3.44.3 y Google Maps.

Análisis estadístico: Regresión lineal multivariada ajustada por edad, sexo, días entre visitas, IMC, diabetes y tabaquismo.

Figura 1. Geocodificación de domicilios y CAP



RESULTADOS

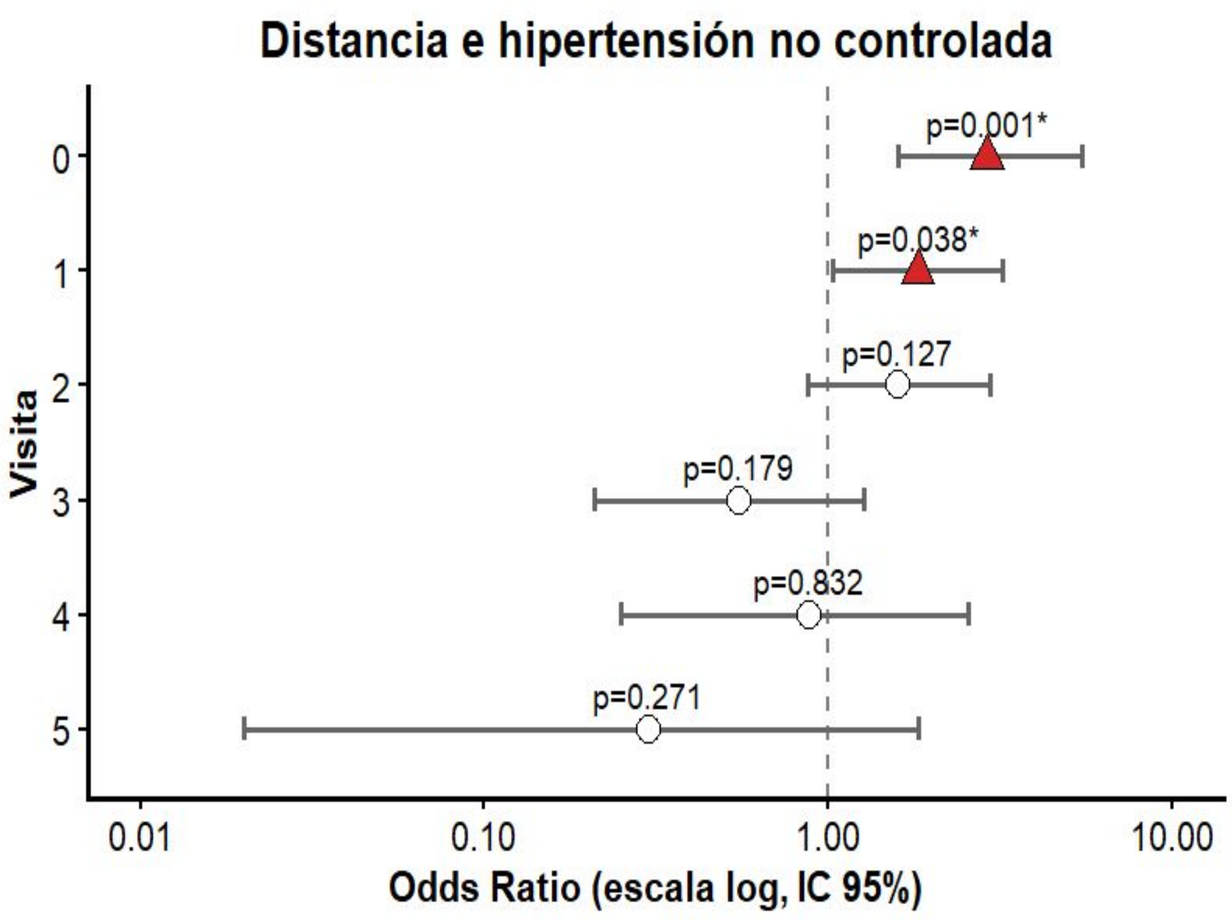
Se evaluaron 634 participantes
Edad promedio de 61 años
71% mujeres; 29% con diabetes
5.4% fumadores e IMC 27.8±5.0 kg/m².

La PAS basal fue 141 mmHg y el 50% presentó control (<140 mmHg).

La Mayor distancia al CAP se asoció con mayor PAS inicial (β=3.97; IC95%: 0.09–7.85), asociación que perdió significancia durante el seguimiento hasta 12 meses.

Una mayor distancia se asoció con:
- hipertensión no controlada al inicio (OR=2.90; IC95%: 1.60–5.46) y en la primera visita (OR=1.82; IC95%: 1.03–3.22)

Figura 2. Asociación entre la distancia al centro de atención primaria y el no control de la hipertensión.



CONCLUSIÓN

La distancia geográfica se asoció con mayores niveles PAS y menor control de hipertensión. Estas asociaciones se atenuaron después de 2 visitas de una intervención comunitaria basada en TCS.

REFERENCIAS
1. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1,201 population-representative studies. Lancet. 2021;398(10304):957–80.
2. Lopez-Lopez JP, Giraldo-Castrillon Y, Otero J, Torres C, Castañeda-Hernandez A,Martinez-Bello D, Garcia C, Lopez-Cabrera M, Lopez-Jaramillo P. Perceived.Barriers and Facilitators in Cardiovascular Risk Management in Colombia: A Qualitative Analysis of the RE-HOPE Study. Int J Environ Res Public Health. 2025 Jul 31;22(8):1199. doi: 10.3390/ijerph22081199. PMID: 40869784; PMCID:PMC12386406.